19. RESUME DE LA STRUCTURATION VASCULAIRE PAR LA CAVITE AMIOTIQUE

DURÉE : 05:54 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo explore en profondeur la structuration vasculaire par la cavité amniotique, mettant en lumière son intégration avec le système vitellin et son rôle dans le développement embryonnaire. Les concepts clés abordés incluent le mouvement de résorption vers le centre de l'embryon, l'intégration artérielle, et l'importance de la cavité amniotique dans la redéfinition des espaces internes. Les mouvements essentiels tels que la céphalisation, l'enroulement embryonnaire, et le rapatriement des fluides sont discutés, tout en soulignant l'impact du système notochordal et du tube neural. Cette connaissance est cruciale pour les praticiens cherchant à reconnaître les dynamiques internes qui influencent la santé embryonnaire et le bien-être global.

RÉSUMÉ DE LA STRUCTURATION VASCULAIRE PAR LA CAVITÉ AMNIOTIQUE

L'ORIGINE ET L'INTÉGRATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Le **système vasculaire**, à sa périphérie, est fortement intégré dans le **système vitellin**. La **cavité amniotique**, initialement de la même taille que la vésicule vitelline, joue un rôle fondamental.

L'embryon s'allonge et grandit considérablement. L'importance de cette cavité amniotique réside dans sa capacité à intégrer complètement le système vitellin. Ce mouvement est crucial et constitue le point central de notre étude.

LE MOUVEMENT DE RÉSORPTION ET LA ZONE B

Dans ce mouvement, tout le système vitellin se résorbe vers le centre de l'embryon, réintégrant l'ensemble. Cette cavité amniotique, que l'on peut désigner comme la **zone B**, en rapport avec le système aortique, aspire tout vers le centre.

Ce processus se déroule à la fois sur un plan **transversal abdominal** et **thoracique**.

Avec la croissance et l'établissement du cœur, ainsi que le développement important du cerveau, la cavité amniotique prend le dessus. Elle englobe complètement tout l'espace du **cœlome externe**. Seule une partie de ce cœlome interne sera intégrée en un cœlome interne. Plus la cavité amniotique grandit, plus le système s'intègre.

L'INTÉGRATION ARTÉRIELLE ET L'ENROULEMENT EMBRYONNAIRE

Deux éléments clés résument l'intégration du système artériel, de la périphérie vers le centre : la **céphalisation** et l'**enroulement embryonnaire**. Cela inclut la cardialisation, la diaphragmatisation et l'hépatisation.

La cavité amniotique agit comme un mouvement d'intégration, redéfinissant les espaces. Dans cette dynamique, tant horizontalement que verticalement, se construit la zone B. La vésicule vitelline, contenant l'information primitive au plan veineux, interagit avec l'extérieur pour réintégrer le corps et le système veineux.

LE RÔLE DES FLUIDES ET DE LA VÉSICULE VITELLINE

Le secret réside dans le **rapatriement des fluides** vers le centre, avec le système fascial jouant un rôle prépondérant dans cette libération.

La vésicule vitelline est une grande source d'information. Le mouvement d'intégration comprend :

- La transformation du cœlome externe en un cœlome interne.
- La fermeture du tube neural.
- L'intégration et le mouvement vers le centre.
- La construction, orchestrée par la cavité.

REDONNER LA CAVITÉ ET LA ZONE B

L'objectif est de redonner cette cavité et la zone B pour réintégrer la circulation interne.

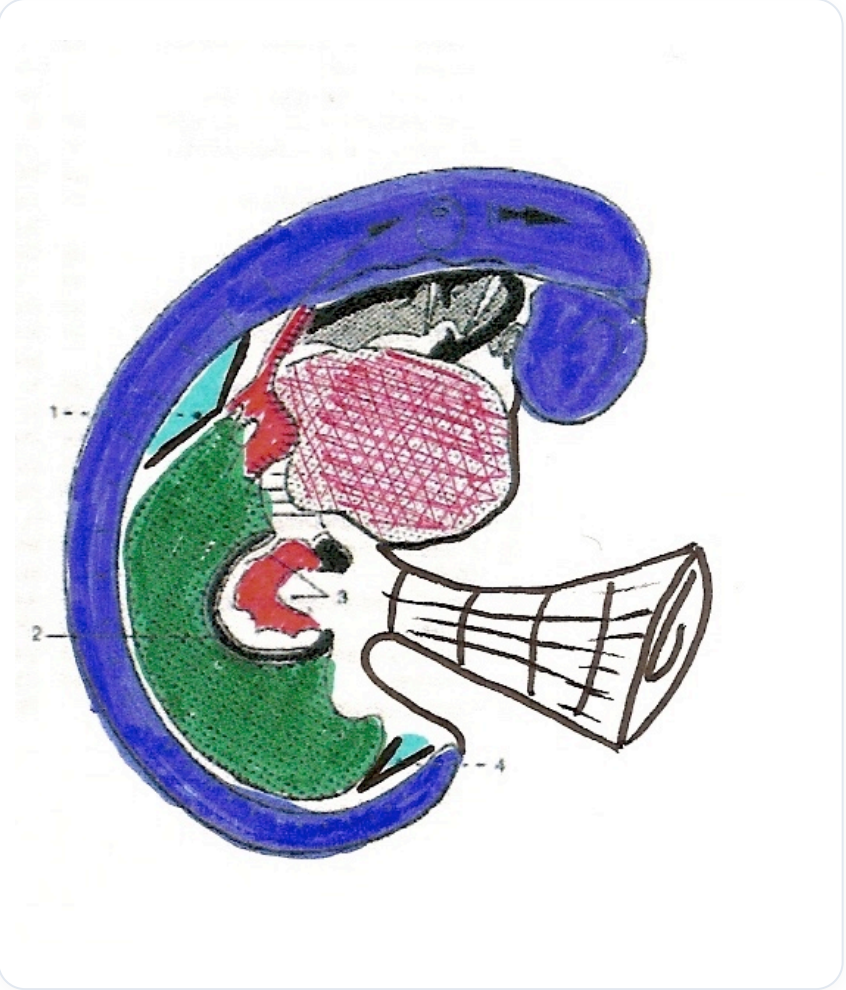


FIG. — Réintégration du système circulaire

En visualisant le schéma comme une personne allongée :

- En bleu, l'intégration en un tube neural.

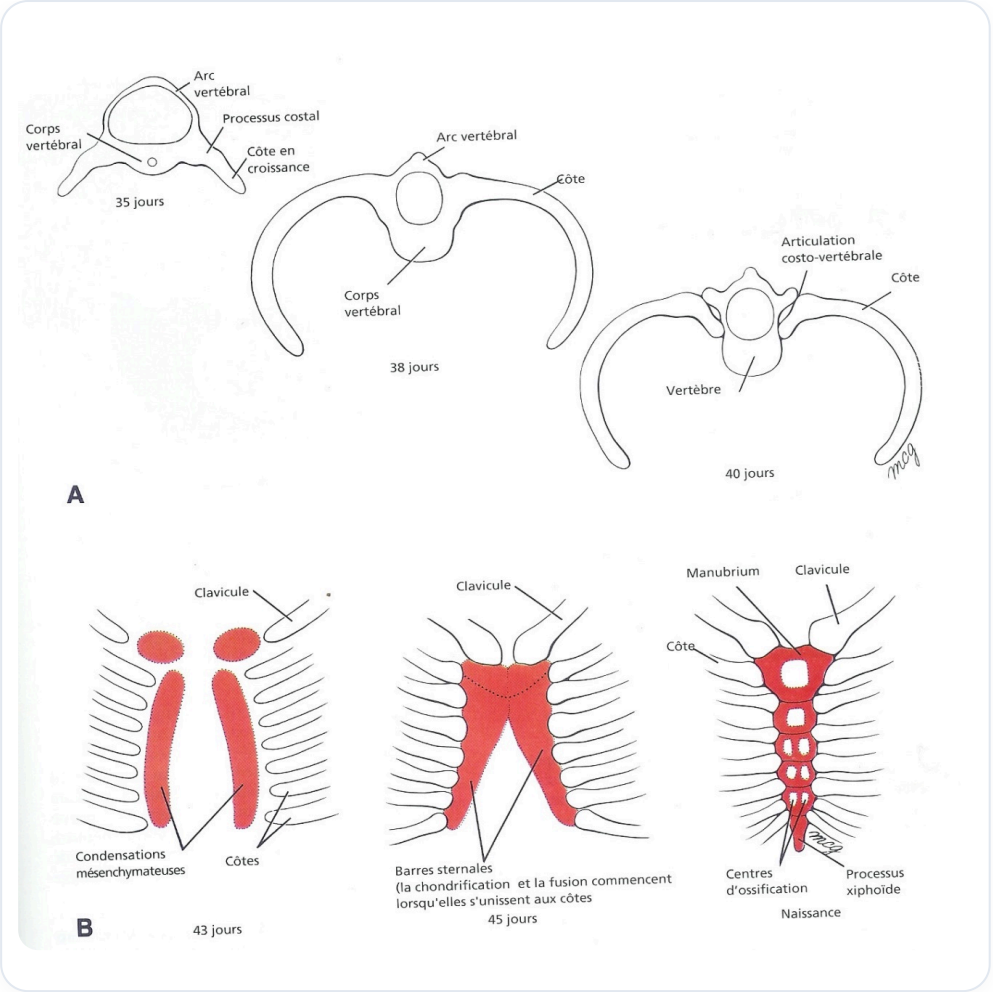


FIG. — Détail de l'intégration du système nerveux

- Le reste formant la peau, une couche **ectodermique**.

Simultanément, l'intégration de la vésicule vitelline contribue à former une partie du système digestif, tandis que tout le système veineux s'intègre. Le mouvement à suivre est celui de la cavité amniotique qui grandit, menant à une fusion pour former la partie longitudinale, le tube digestif.

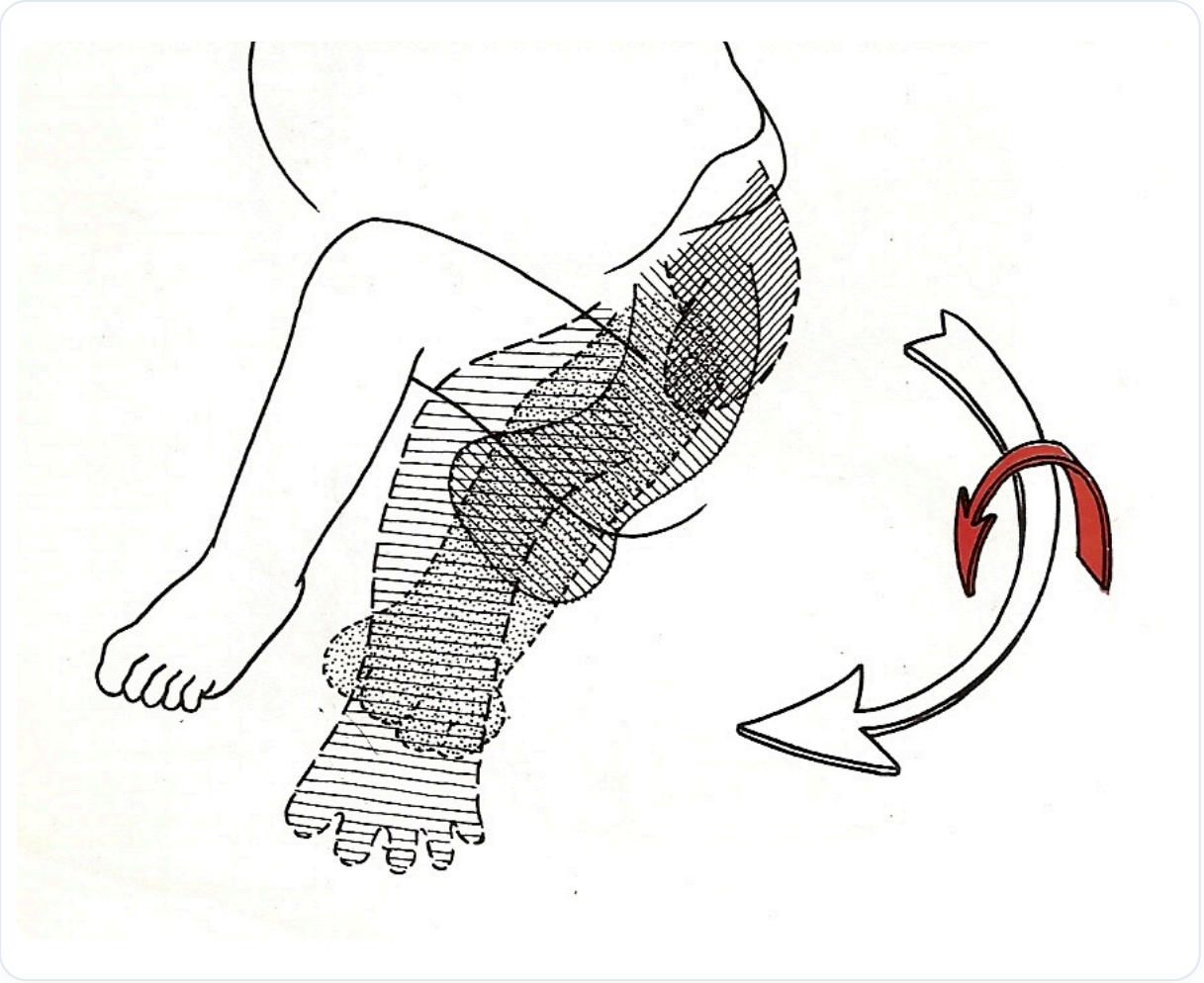


FIG. — Étape de la formation du tube digestif

L'intégration du cœlome externe en un futur cœlome interne est visualisée en jaune, où tout se rejoint sur la ligne médiane.

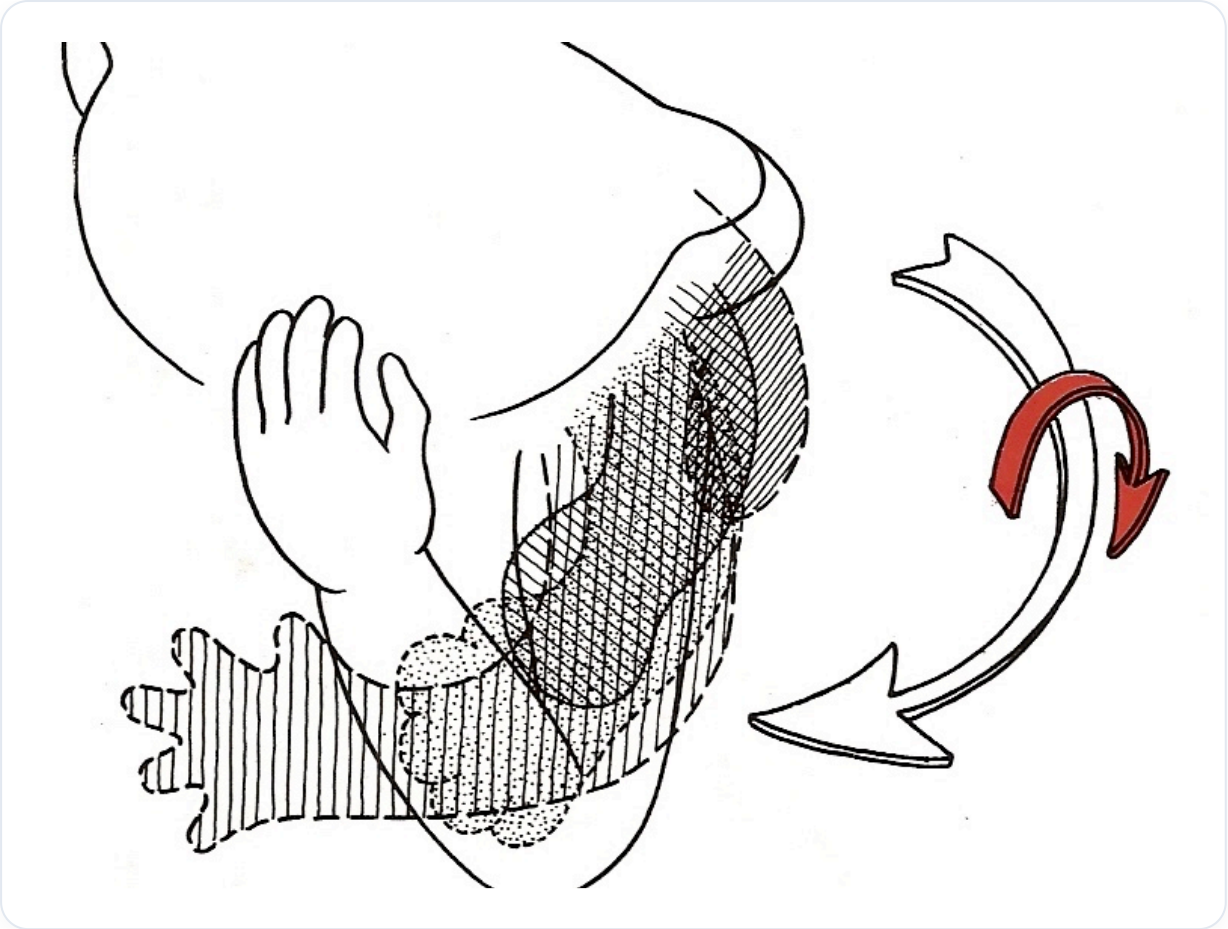


FIG. — Convergence des structures vers la ligne médiane

LE GRAND MOTEUR : SYSTÈME NOTOCHORDAL ET TUBE NEURAL

Le moteur principal de ce processus est le **système notochordal**, qui influence le tube neural et organise le système vasculaire primitif aortique. Il redirige l'information avec l'intégration progressive de tout le système transversal, de la périphérie vers le centre.

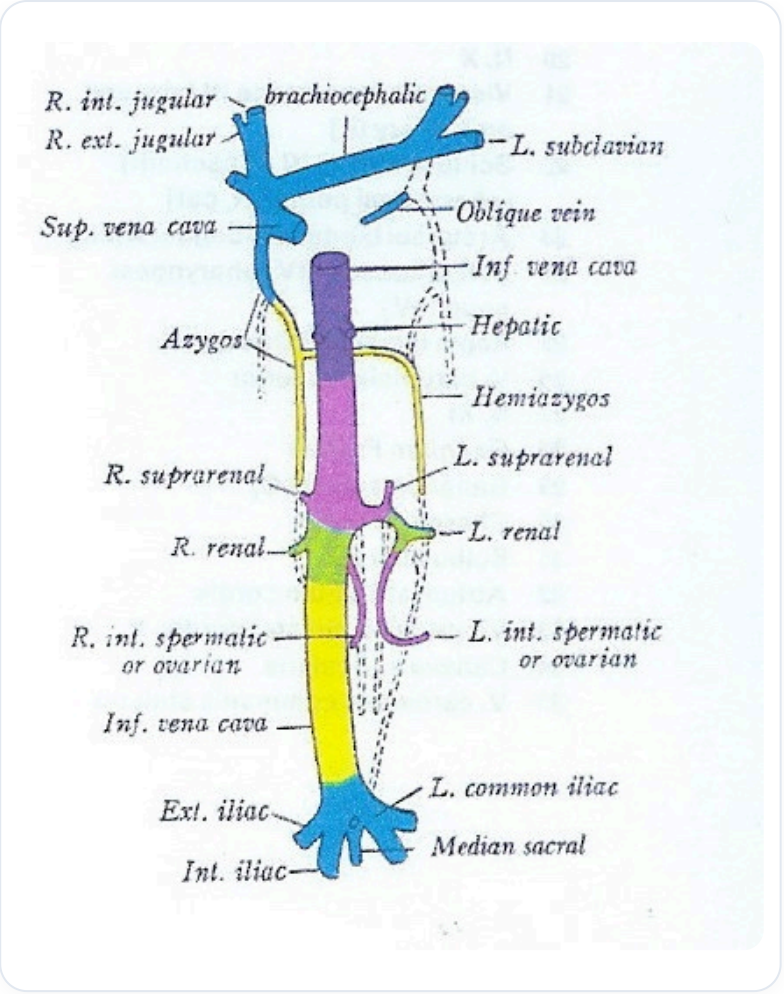


FIG. — Système notochordal ou une vue transversale de l'intégration, correspondant au texte

Nous allons suivre ce mouvement pas à pas. Il est essentiel de "laisser faire" la respiration primaire.

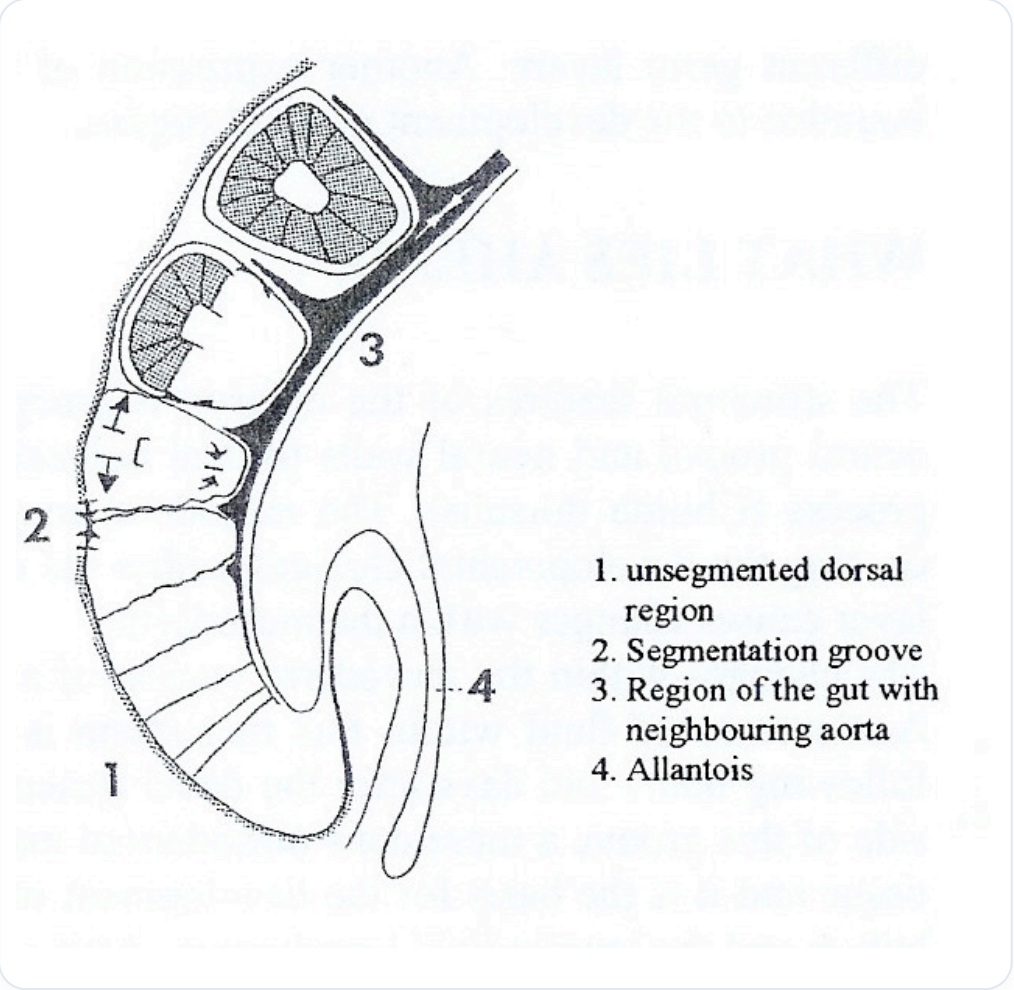


FIG. — L'image la structure veineuse viscérale mentionnée dans le résumé, et cette phrase marque une transition vers la notion de 'mouvement'

MOUVEMENT ENDOVOLONTAIRE DES POUMONS ET CONSCIENCE DU PÉDICULE OMBILICAL

Le **mouvement endovolontaire des poumons** part de l'endoderme et est orienté par le système vasculaire.

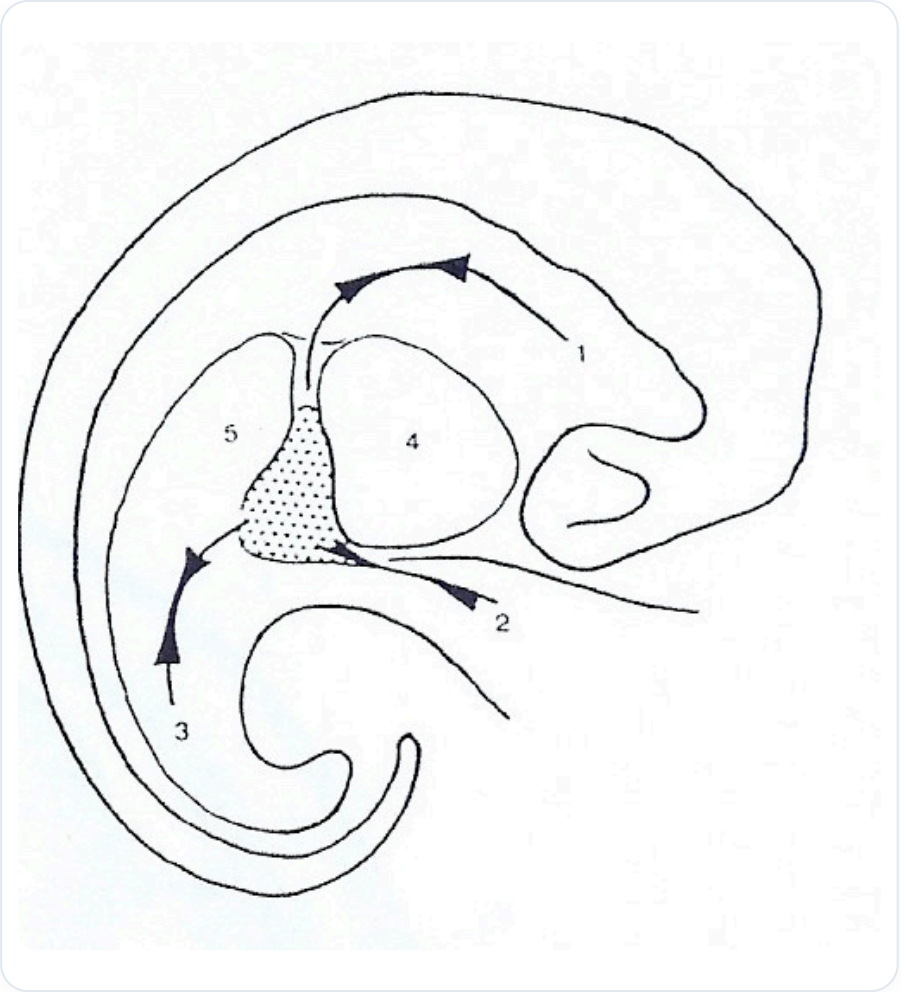


FIG. — L'image correspond à la description de l'intégration des systèmes comme le vitellin et hépatique

La conscience du **pédicule ombilical** doit revenir dans cet espace, permettant de percevoir la force de la cavité amniotique qui grandit, tout en intégrant les processus de céphalisation, cardialisation, diaphragmatisation et hépatisation.

Le retour se fait alors.

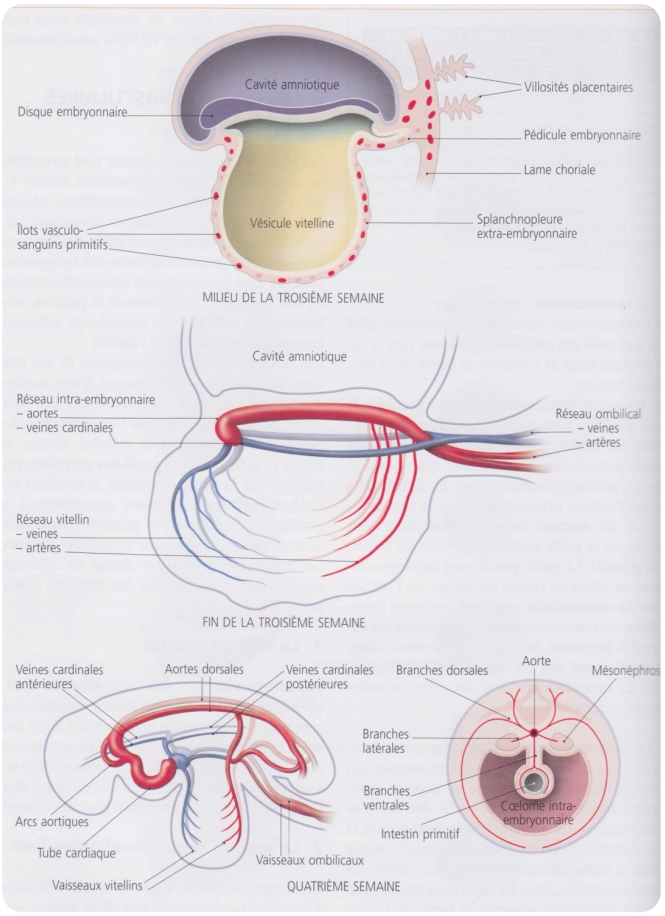


FIG. — Régression de la vésicule vitelline et la formation du cordon ombilical, ce qui est logique après la mention du 'retour'

La vésicule vitelline, poussée par la vitesse de croissance différentielle, sera reprise dans le schéma.

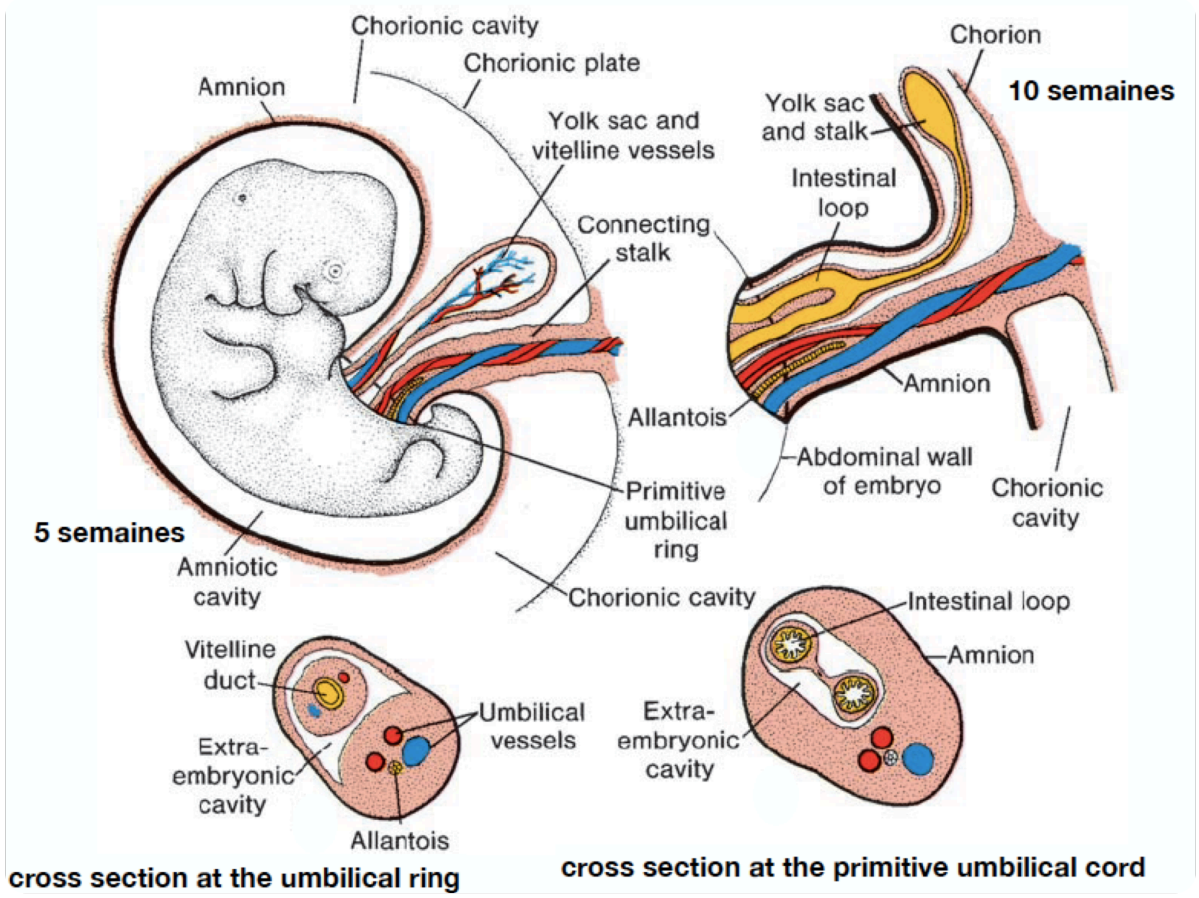


FIG. — Cordon ombilical formation

Elle va repousser le pédicule pour rejoindre la vésicule vitelline et former plus tard le cordon ombilical.

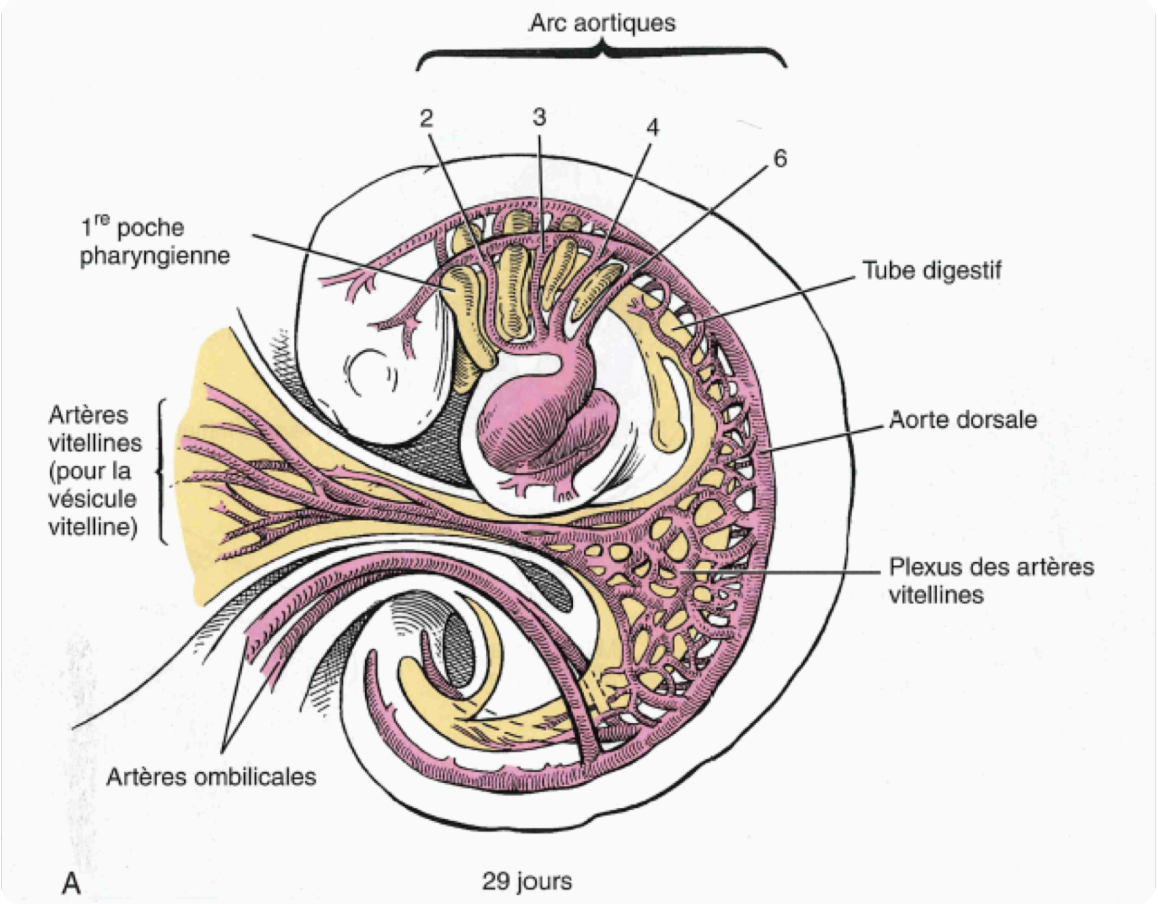


FIG. — Intégration du système vitellin et de ses vestiges

Tout se rejoint ici, partant d'un pédicule pour revenir à un cordon.

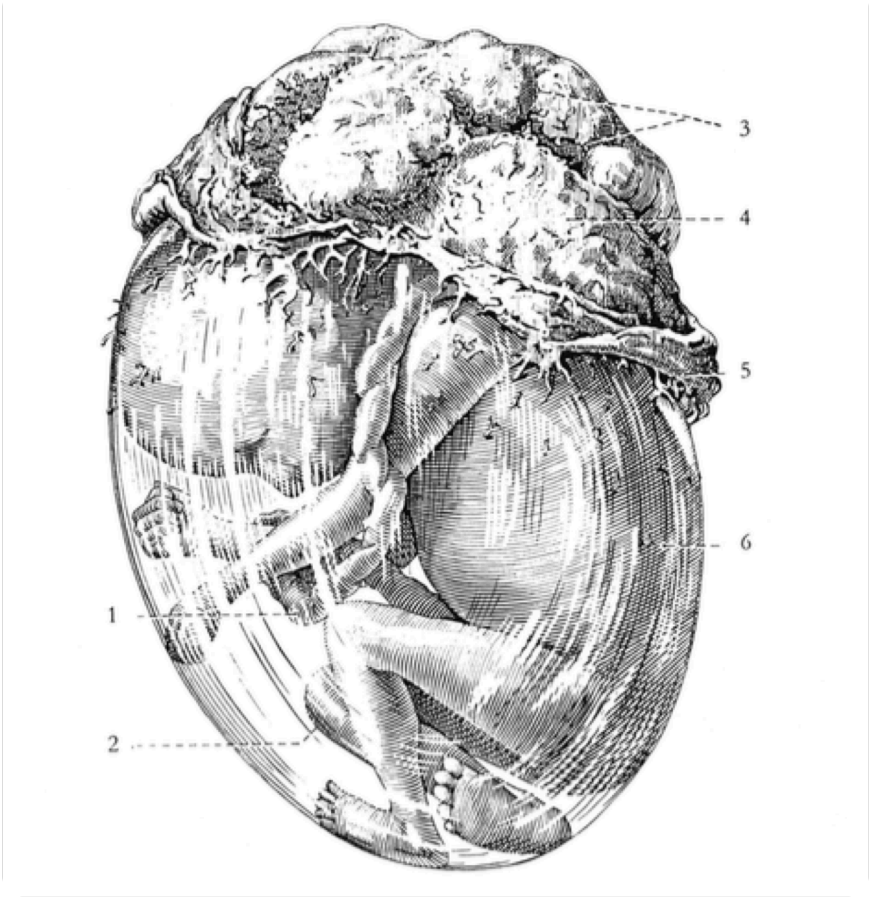


FIG. — Fœtus dans l'utérus